

02 - 02- Maladie ulcéreuse gastro-duodénale - Pr. Krati

(0:00 - 0:32)

La maladie ulcéreuse, gastro-adrénale ou ce qu'on appelle aussi l'ulcère gastro-adrénale, c'est une maladie chronique en absence de traitement. C'est une maladie qui va évoluer par poussée et qui est caractérisée par la présence d'un ulcère catéiforme qui peut se compliquer. Son diagnostic repose sur l'endoscopie qui permet de mettre en évidence cette ulcération.

(0:33 - 1:10)

Et c'est une maladie dont l'éthiopathogénie fait intervenir plusieurs facteurs et le facteur principal reste les glucobactères puloris. C'est un facteur étiologique important qui a permis de comprendre la physiopathogénie et de proposer un traitement qui a modifié l'histoire de cette maladie qui était longtemps restée une maladie chronique récidivante qui est devenue une maladie curable. On peut dire que c'est une maladie qu'on peut considérer comme liée infectieuse.

(1:11 - 2:02)

Cette maladie a largement profité de tous les progrès réalisés en thérapeutique, puisque la découverte et l'utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons a permis de réduire les ulcères gastro-dénales résistants au traitement médical et réduire ainsi les indications de la chirurgie dans cette maladie. Et comme je l'ai dit, l'éradication de glucobactères puloris permet de modifier l'histoire de la maladie et d'éviter la récurrence de la maladie et la maladie devenue curable. Sur le plan anatomopathologique, la maladie ulcéreuse se caractérise par un ulcère.

(2:02 - 2:38)

Cet ulcère est une perte de substance profonde et localisée. C'est une perte de substance de la muqueuse profonde qui va dépasser la musculaire muqueuse, ce qui permet de la faire distinguer de toutes les pertes de substance de la muqueuse superficielle qui ne dépassent pas la musculaire. Comme les ulcérations, les exulcérations, les érosions qui restent superficielles.

(2:40 - 3:08)

Sur le plan anatomopathologique, macroscopiquement, il réalise une perte de substance sous forme d'un cratère qui peut être rond ou ovale, de taille variable, avec des bords réguliers sur lesquels convergent les plus muqueux. Cet aspect, on le voit, il est bien visible sur l'endoscopie. Microscopiquement, on a les caractères de chronicité de l'ulcère.

(3:09 - 3:37)

On a de la fibrine avec de l'oxydation, avec de la glécrose fibrinoïde, avec du tissu de granulation

au fond et de la fibro. La maladie ulcéreuse reste une maladie fréquente qui touche tous les payés. C'est une maladie qui touche aussi bien l'homme que la femme, avec un âge moyen.

(3:38 - 4:06)

Pour les ulcères gastriques, l'âge est de 65 ans. C'est un peu plus élevé que pour les ulcères duodénos qui sont de 55 ans. La maladie ulcéreuse peut être grave lorsqu'elle n'est pas prise en charge et se complique par certaines complications, notamment les hémorragies digestives ou la perforation.

(4:10 - 4:45)

Sur le plan physiopathologique, il faut savoir que l'ulcère, cette perte de substance, est secondaire à un déséquilibre entre les facteurs d'agression de la muqueuse et les facteurs de protection. Au niveau de la muqueuse gastrique, il y a une sécrétion des ions H^+ . Dans la lumière gastrique, il y a les ions H^+ , qui vont bien sûr être déversés directement au niveau du duodenum.

(4:45 - 5:31)

Sauf qu'à l'état physiologique, la muqueuse se protège par le mucus, par les bicarbonates, par la régénération de la muqueuse, par sa vascularisation. Il y a tout un système qui permet à la muqueuse de se protéger contre cette agression essentiellement acide. Lorsque cet équilibre est atteint, lorsqu'il est défaillant, il y a une apparition de l'ulcère, soit au niveau de la muqueuse gastrique, soit au niveau de la muqueuse duodenale, sur l'ulcère duodenale.

(5:35 - 6:36)

La question qui se pose, c'est pourquoi il y a cet déséquilibre ? En fait, le déséquilibre fait qu'il y a l'apparition de l'ulcération. Mais il faut savoir que le déséquilibre peut être lié à une augmentation des facteurs d'agression qui peuvent dépasser les facteurs de protection de la muqueuse, soit la sécrétion d'acides où les facteurs d'agression sont normaux, voire même diminués, mais c'est les facteurs de protection qui sont très diminués et qui n'arrivent pas à contrebalancer les facteurs d'agression. C'est pour ça que le dogme dit qu'on ne peut pas avoir de l'ulcère si on n'a pas d'acide.

(6:36 - 7:26)

Cela ne veut pas dire que tous les ulcères s'accompagnent d'une augmentation de la sécrétion acide, mais ce qui se passe, c'est soit qu'on a une augmentation de la sécrétion acide, soit que la sécrétion acide est normale, voire diminue, mais on a une atteinte ou une diminution des facteurs de protection qui fait que cette sécrétion acide, même si l'acide est minime, est capable d'agresser cette muqueuse qui est incapable de se protéger. Et ce déséquilibre peut se revenir lorsqu'il y a certains facteurs étiologiques. Le facteur étiologique le plus important, c'est le leucobacter pylori.

(7:27 - 7:52)

Je ne vais pas trop insister sur le leucobacter pylori, même si c'est le facteur primordial, parce qu'on a eu le cours sur le leucobacter pylori et les lésions gastrointestinales que nous avons détaillées. Donc je passerai très rapidement sur le leucobacter pylori. Le deuxième facteur qui est aussi important, certes moins que le leucobacter pylori, mais qui reste aussi dominant, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens.

(7:52 - 8:10)

Et il y a d'autres facteurs aussi, c'est les ulcères de stress, la maladie de Crohn, etc. Nous allons les discuter. Donc pour le leucobacter pylori, c'est le facteur primordial.

(8:11 - 8:34)

C'est le facteur primordial et c'est le facteur très pondérant dans les étiologies. D'ailleurs, certains auteurs disent même que c'est vrai que s'il n'y a pas d'acide, il n'y a pas d'ulcère. Mais il y a d'autres auteurs qui disent qu'en plus, s'il n'y a pas de leucobacter pylori, il n'y aura pas d'ulcère.

(8:34 - 9:00)

Et en effet, vous voyez que sur ces images, la majorité des ulcères duodénaux et des ulcères gastriques sont liés au leucobacter pylori. Donc vous voyez, la majorité vient en deuxième position. Les anti-inflammatoires, le reste représente une partie très fine.

(9:00 - 9:30)

Et entre l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal, on voit que les anti-inflammatoires donnent plus des ulcères gastriques que des ulcères duodénaux. Pour résumer, je dirais que le leucobacter pylori agit de deux façons pour entraîner l'ulcère. D'abord, il peut agir en augmentant la sécrétion acide et aussi en altérant les moyens de protection.

(9:30 - 10:05)

Le mucus, il peut entraîner aussi l'atrophie de la muqueuse gastrique, etc. Il a aussi un effet cytotoxique direct sur la muqueuse gastrique, comme nous avons vu dans le cours précédent. Donc, le leucobacter pylori entraîne un ulcère gastrique ou duodénal par des mécanismes multiples qui vont agir de façon synergique pour entraîner l'ulcère gastrique ou duodénal.

(10:06 - 10:43)

Le deuxième facteur radiologique important qui vient après le leucobacter pylori, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Déjà, il faut savoir que ces anti-inflammatoires non stéroïdiens

peuvent entraîner des lésions des ulcères, donc des lésions gastro duodénales et des ulcères, sur le sujet âgé plus que sur le sujet jeune. Donc, c'est certains sujets qui ont une susceptibilité individuelle pour développer des lésions.

(10:44 - 11:19)

Il faut savoir aussi que les ulcères liées aux anti-inflammatoires sont le plus souvent hémorragiques. Donc, le risque hémorragique est le plus important dans les ulcères gastro duodénales liées aux anti-inflammatoires. Et ces anti-inflammatoires non stéroïdes peuvent être agressifs pour la muqueuse gastrique, que ce soit le mode de prise, que ce soit par voie orale ou par voie injectable.

(11:21 - 13:37)

En plus, pour les anti-inflammatoires non stéroïdes, ils peuvent entraîner aussi un effet local direct au niveau de la muqueuse, c'est l'action directe. Et ils ont aussi une action systémique, c'est pour ça qu'ils peuvent entraîner un ulcère, quel que soit le mode de prise, parce que les anti-inflammatoires non stéroïdes non sélectifs, c'est-à-dire qui inhibe la COX-1 et la COX-2, ils vont inhiber la transformation de l'acide arachidonique vers les deux prostaglandins, ce qui va entraîner des lésions de l'endothélium vasculaire, ce qui va entraîner la diminution de la vascularisation au niveau de l'estomac, ce qui va entraîner aussi la libération, la sécrétion de bicarbonate, la diminution de la sécrétion de muqueuse, ce qui va entraîner le retard ou l'inhibition de la cicatrisation des lésions de la muqueuse, ce qui favorise le développement des ulcères. Les autres causes qui sont plus rares, c'est les ulcères de stress, ça c'est bien connu chez les patients, par exemple, qui sont hospitalisés en unité de soins intensifs, qui sont gravement malades, comme les polytraumatisés, les patients qui ont des chocs septiques ou hypovolémiques, des atteintes multiviscérales.

Chez ces patients, il peut y avoir des ischémies de la muqueuse, ce qui rend cette muqueuse fragile et favorise le développement des ulcères. Certains patients qui présentent des tumeurs non endocrines qui sécrètent de la gastrine. Comme vous le savez, la gastrine, c'est une hormone qui favorise la sécrétion des acides.

(13:37 - 14:00)

Ces tumeurs sont appelées les tumeurs gastrinomes, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Zollinger et Ellison. Ce sont des tumeurs rares, mais c'est possible. Dans ce cas, on ne va pas trouver un seul ulcère, on va trouver de multiples ulcères, aussi bien au niveau de l'estomac qu'au niveau du duodénum.

(14:02 - 14:52)

Il y a aussi la maladie de Crohn qui peut donner des ulcères profonds, mais généralement ce

sont des ulcères granulomateux. Cela survient dans un contexte très évocateur de la maladie de Crohn. Il y a aussi les facteurs agressifs, comme par exemple une ingestion d'ACL ou ce qui peut donner un ulcère, mais là aussi le contexte est évident.

Chez certains patients, cela représente 10%, l'ulcère peut survenir sans aucune cause évidente. À côté de ces causes, il y a certains facteurs qui peuvent favoriser le développement de l'ulcère, notamment l'hérédité, c'est la prédisposition génétique. On voit que dans certaines familles, ils ont plus d'ulcères que d'autres.

(14:52 - 15:57)

Le tabac favorise le développement des ulcères parce qu'il augmente la masse pariétale, donc augmente la sécrétion ainsi. Le tabac aussi ralentit la cicatrisation parce que le tabac, en plus, favorise la résistance du glycobactère au traitement. Il favorise aussi la récurrence.

Il y a aussi l'alcool qui augmente le risque des ulcères hémorragiques, en particulier ceux qui sont associés aux anti-inflammatoires parce qu'il favorise les gastrites. L'alcool est à l'origine de certaines gastrites. Il faut savoir que certains facteurs sont aussi suspectés pour favoriser le développement de l'ulcère, comme les corticoïdes, le stress psychique, etc.

(16:00 - 17:23)

Maintenant, comment se développe l'ulcère duodénal ? L'ulcère duodénal est secondaire à une hypersécrétion acide qui va fragiliser la muqueuse vulvaire. Pourquoi il y a cette hypersécrétion acide ? En fait, le glycobactère *pulori* entraîne, comme je l'ai dit, une gastrite interstitielle qui va entraîner une hypersécrétion acide. Il a aussi un autre effet.

Il diminue la sécrétion de la somatostatine et augmente la sécrétion de la gastrite. Cette hypersécrétion va être à l'origine d'une élimination d'un chyme gastrique riche en acides au niveau du duodénum qui va le fragiliser et va être à l'origine d'une transformation de la muqueuse duodénale en muqueuse gastrique. C'est ce qu'on appelle la métaplasie gastrique duodénale qui va être secondairement colonisée par le glycobactère qui va agresser la muqueuse et entraîner l'ulcération.

(17:24 - 18:32)

C'est vrai qu'il y a encore pourquoi l'ulcération siège à un endroit bien précis. Il y a certains points d'interrogation. Ce qui est très important à retenir, c'est que dans l'ulcère duodénal, le glycobactère *pulori* est responsable d'une gastrite interstitielle superficielle qui s'accompagne d'une hypersécrétion acide qui est à l'origine d'une inflammation au niveau du duodénum avec la constitution d'une métaplasie qui rappelle la muqueuse gastrique pour s'adapter à cette sécrétion acide.

Malheureusement, sur cette métaplasie va se constituer donc l'ulcère duodénal. Dans l'ulcère

gastrique, on voit qu'il n'y a pas d'hypersécrétion acide. La sécrétion acide est normale ou diminuée.

(18:34 - 19:15)

La gastrite et le *glycobactère pulori* évoluent en deux phases. La première phase, c'est la phase où la gastrite est localisée au niveau de l'antré, où il y a un infiltrant inflammatoire sans atteinte glandulaire, sans atrophie. C'est dans cette gastrite interstitiale que généralement il y a l'hypersécrétion qui expose au risque de l'ulcère diodénale.

(19:15 - 19:47)

La gastrite et le *glycobactère* évoluent vers une diffusion de l'atteinte. Il ne va plus être limité uniquement à l'antré, mais il va s'étendre au niveau du corps gastrique, au niveau du fendice. Lorsque l'atteinte devient plus profonde, il va intéresser les glandes et entraîner une atrophie glandulaire, donc une fragilisation de la muqueuse, et en même temps une diminution de la sécrétion acide.

(19:47 - 20:24)

Sauf que sur cette gastrite atrophique liée généralement au *glycobactère pulori*, même si on a une sécrétion qui est la diminution normale d'acide, les facteurs de protection vont être diminués parce qu'il y aura une diminution aussi bien de la synthèse de bicarbonate qu'une diminution de la synthèse de muqueuse. La régénération de la muqueuse ne va pas se faire en cas d'agression. Tout cela va favoriser le développement de l'ulcère gastrique.

(20:26 - 20:53)

Ce qui est aussi important à préciser, c'est que la gastrite atrophique est un lit d'ulcère gastrique, mais elle peut aussi être un lit de dysplasie et de cancer gastrique. C'est pour cela qu'un ulcère gastrique doit toujours faire craindre l'association ou la présence d'un cancer. C'est pour cela qu'on fait en général les biopsies au niveau de l'ulcère gastrique.

(21:00 - 21:45)

Après cette introduction et ce rappel physiopathologique, dans quelle situation il faut penser à l'ulcère gastro-diodéline ? L'ulcère gastro-diodéline peut se révéler par un tableau caractéristique très évocateur. C'est ce qu'on appelle le syndrome ulcérotupique. C'est quoi le syndrome ulcérotupique ? C'est tout simplement une douleur qui siège au niveau de l'hépicastre, qui n'a pas de radiation particulière, qui est à tupe de crampe, ou ce que le malade peut décrire comme une faim très douloureuse, qui est généralement calmée par la prise alimentaire ou par un menthier assis.

(21:45 - 22:05)

On dit qu'il est rythmé par le repas. Il va survenir à distance du repas, une heure ou trois heures après le repas. En absence de traitement, cette douleur va évoluer par poussée pendant quelques semaines, puis il peut disparaître et réapparaître après.

(22:05 - 22:21)

Là, c'est le syndrome ulcérotypique. En général, un patient qui vient vous voir dans votre cabinet va vous dire qu'il a mal, qu'il a faim. On pense très rapidement à l'ulcère et on demande l'endoscopie.

(22:22 - 22:35)

Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'ulcère peut se manifester par des signes moins typiques. Il peut se manifester par des signes moins typiques, comme le syndrome douloureux.

(22:36 - 22:56)

La douleur existe, mais c'est une douleur qui n'est pas atype de crampe, atype de brûlure. Ou c'est une douleur qui n'est, on ne trouve pas ce caractère, calmée par les repas, survenant à jeûne, etc. Il peut aussi être atypique par son siège.

(22:56 - 23:24)

Au lieu d'être hypigastrique, il peut être latéralisé un peu à gauche, un peu à droite, parfois même perambulical. Donc, les atypiques peuvent intéresser aussi bien le siège que l'ulcère, que l'absence de ce caractère rythmé par le repas qui est très caractéristique. Il faut savoir aussi que l'ulcère gastrique peut être asymptomatique chez 20% des patients.

(23:24 - 23:40)

En particulier chez les patients, par exemple, qui prennent des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des corticoïdes. Chez les sujets âgés, parfois. Chez les diabétiques, parce qu'ils ont des troubles, une diminution de la sensibilité.

(23:41 - 24:13)

Lorsqu'il est asymptomatique, il peut être malheureusement révélé par une complication ou par une endoscopie réalisée pour une autre raison que la suspicion de l'ulcère. Certains ulcères peuvent être d'emblée compliqués, révélés par une complication. Comme on va le voir dans le chapitre de complication.

(24:14 - 24:49)

L'examen clinique dans les ulcères gastro-diurnaux non compliqués est pauvre. C'est un examen qui va être tout à fait normal. C'est pour ça qu'avant l'endoscopie, le diagnostic de

l'ulcère gastro-diurnale, devant ces circonstances découvertes qui attirent l'attention vers l'épigastre, se pose avec toutes les maladies qui peuvent aussi donner des symptômes au niveau de l'épigastre.

(24:49 - 25:04)

Notamment les cancers gastriques, que ce soit un adénocarcinome ou un lymphome. Il peut se manifester l'épigastrique qui peut être parfois très évocatif d'un ulcère gastro-diurnale. Ils peuvent avoir le caractère du syndrome ulcéreux.

(25:06 - 25:32)

C'est pour ça que devant même la symptomatologie très évocatrice, il faut faire l'endoscopie. Il faut aussi qu'il y ait la pathologie pancréatique. Que ce soit un cancer, une pancréatite chronique ou une pancréatite aiguë, ils ont des épigastriques et on sait que ces douleurs peuvent parfois être moins typiques.

(25:33 - 26:02)

On sait aussi que les douleurs de l'ulcère peuvent être moins typiques, moins évocatrices de l'ulcère. C'est pour ça qu'il faut chercher, préciser les caractères, avoir moins de redoutes, faire le bilan nécessaire. Par exemple, on sait que la douleur au cours de la pancréatite aiguë ou en cas de poussée, c'est une douleur en côte poignarde qui est radiée vers le dos, qui est soulagée par la position en pédophilie.

(26:03 - 26:24)

Contrairement à celle de la douleur ulcéreuse, c'est une douleur qui est provoquée par l'alimentation. Mais tous ces caractères peuvent être défaillants. C'est pour ça que chez un patient qui est éthylique, il faut penser au pancréat et il faut rechercher ces caractères de la douleur.

(26:25 - 26:54)

Il y a aussi les cancers pancréatiques qui peuvent donner des épigastriques. En absence de douleurs typiques d'ulcère, ou si on fait une endoscopie et qu'on ne trouve pas de lésions ulcéreuses, il faut penser à cette pathologie. Il y a aussi les pathologies biliaires, notamment une lithiase vésiculaire qui peut donner des épigastriques.

(26:55 - 27:16)

Il y a aussi la cholecystite qui peut donner des épigastriques. Mais l'examen clinique est très caractéristique parce qu'on va trouver une douleur de l'hypocondre droit qui est provoquée par la palpation, qui va inhiber la respiration. Et donc ça, c'est très caractéristique, très évocateur.

(27:16 - 27:32)

Une lithase glabulaire principale peut donner aussi des épigastries. Attention, il faut penser aussi aux insuffisances coronariennes, notamment un impact du myocarde en manifestation digestive. Il peut se manifester par des épigastries.

(27:32 - 27:46)

Mais là, c'est un terrain particulier, c'est un sujet âgé. Il y a des facteurs de risque de l'insuffisance coronarienne. Mais il faut l'avoir en tête.

(27:46 - 28:05)

Au moindre doute, il faut savoir rechercher l'infarctus du myocarde car c'est une urgence thérapeutique. L'infarctus mésentérique peut aussi donner des épigastries. Mais c'est généralement les douleurs qui sont très intenses, contrastant avec un examen clinique fort.

(28:06 - 28:15)

Donc là aussi, il faut voir le terrain. Au moindre doute, il faut demander une image. Il y a aussi les douleurs vertébrales projetées.

(28:15 - 28:34)

Parce qu'au niveau derrière l'épigastre, il y a les vertèbres dorsales et l'ombilic supérieur. Parfois, on peut avoir une lésion vertébrale qui peut donner une douleur qui se projette au niveau de l'épigastre. L'intérêt de faire l'examen clinique est toujours d'appuyer sur les vertèbres.

(28:34 - 28:53)

Et donc là, on appuie sur la vertèbre, on va déclencher la douleur et on fait le diagnostic. Il y a toutes les gastrites, les dyspepsies non ulcéreuses qui peuvent donner aussi des épigastries. Et c'est pour ça que le diagnostic de l'ulcère gastrointestinal ne peut pas être clinique.

(28:53 - 29:11)

Il doit être confirmé toujours par l'endoscopie. L'endoscopie, c'est l'examen clé pour poser le diagnostic. Donc, il permet de mettre en évidence cette perte de substance, ratéeiforme, à fond blanchâtre, avec des bords réguliers.

(29:12 - 29:33)

Il permet aussi de préciser le siège. Est-ce que c'est un ulcère bulbaire ou est-ce que c'est un ulcère gastrique ? A quel niveau ? Est-ce qu'elle est très pylorique au niveau de l'ongulus ? Au niveau dont il précise le siège. Ce qui est très important, c'est que l'endoscopie permet de

réaliser des biopsies.

(29:33 - 30:05)

A quel niveau faut-il réaliser ces biopsies ? Il faut savoir qu'en cas d'ulcère gastrique, on réalise toujours des biopsies sur l'ulcère lui-même, sur les berges et sur le feu. Et en cas d'ulcère bulbaire ou diodénale, on ne fait pas des biopsies sur l'ulcère lui-même. Donc, retenir que pour l'ulcère gastrique, il est indispensable de faire des biopsies sur l'ulcère lui-même.

(30:06 - 30:27)

Il faut faire aussi des biopsies à la recherche des cobactères pyloriques de façon systématique, aussi bien pour l'ulcère gastrique que pour l'ulcère diodénale. On fait des biopsies, on fait des prélèvements au niveau de l'entre, un prélèvement au niveau de l'ungulus et deux prélèvements au niveau du fundus. On les fait de façon systématique.

(30:28 - 30:47)

Donc, les biopsies à la recherche des cobactères pyloriques doivent être faites, que ce soit un ulcère bulbaire ou un ulcère gastrique. Par contre, les biopsies de l'ulcère ne se feront que sur l'ulcère gastrique. Donc, ça c'est important.

(30:49 - 31:06)

Donc, l'endoscopie recherche l'ulcère, mais doit toujours rechercher d'autres lésions. Donc, il ne faut pas se contenter de voir l'ulcère, en particulier au cas de l'ulcère gastrique, parce qu'il survient sur une mycose atrophique, c'est un lit de cancer aussi. Donc, il faut rechercher, puisqu'il n'y a pas d'autres lésions de cancer.

(31:07 - 31:28)

Bien sûr, il faut réaliser les biopsies. Donc, la découverte d'un ulcère à l'endoscopie doit toujours discuter, est-ce que ce n'est pas un cancer, en cas d'ulcère gastrique. Toujours, c'est pour ça qu'il faut faire les biopsies multiples sur l'ulcération.

(31:29 - 32:08)

Et bien sûr, l'aspect caractéristique permet d'écarter les ulcérations superficielles et les érosions. Il y a un deuxième problème, c'est qu'au niveau de bulle, on peut avoir des ulcérations en rapport avec un lymphome ou avec une maladie de Crohn, mais généralement, ce sont des ulcères qui sont larges et qui n'ont pas tendance à la cicatriser. Sur ce tableau, surtout, on essaie de faire une comparaison entre un ulcère gastrique bénin et un ulcère malin.

(32:09 - 32:46)

Vous voyez que dans l'ulcère malin, on a l'irregularité des berges, les prélèvements, lorsqu'on veut faire le prélèvement avec la pince à biopsie, on sent une induration et les plis qui sont rétractés et épaissis. Mais tout ulcère gastrique, même s'il a tous les caractères d'un ulcère et d'une berge, doit être biopsié, il reste suspect jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'on ait les résultats de l'anatomopathologie.

(32:50 - 33:23)

Une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a retrouvé l'ulcère gastro-dénale, il est très important de rechercher le facteur étiologique. Il faut toujours rechercher, par l'interrogatoire, une prise d'anti-inflammatoires menstruels, un tabagisme. Il faut toujours rechercher les mycobactères pulvorés et ça on l'a dit grâce au biopsie qu'on va faire et qui vont nous permettre de mettre en évidence les mycobactères pulvorés dans la majorité des cas.

(33:24 - 33:59)

C'est très important cette recherche des mycobactères pulvorés au-delà du facteur étiologique parce qu'en traitant le facteur étiologique, on guérit le patient de l'ulcère. On lui évite le risque de récurrence. La maladie ulcéreuse reste une maladie bénigne qui évolue en absence de traitement vers la cicatrisation en 4 semaines.

(34:00 - 34:37)

Cette cicatrisation va survenir entre 40 et 75 %. En absence de traitement, il y a un risque de récurrence de l'ulcère après cicatrisation de 50 % à un an. Pendant cette évolution vers la cicatrisation, il y a toujours un risque de développer une complication, une hémorragie, une perforation, une cystémie. C'est pour ça que même si cette maladie évolue spontanément vers la cicatrisation, il faut proposer le traitement.

(34:37 - 35:02)

Le traitement est garant d'abord de réduire le délai de cicatrisation. Il va nous permettre d'éviter la récurrence et d'éviter les complications mortelles. L'ulcère gastro-duodénal doit être diagnostiqué et doit être repris en charge.

(35:02 - 35:14)

Le traitement va accélérer la procédure de cicatrisation. Il va faire disparaître les douleurs. Il va éviter aux patients de souffrir.

(35:15 - 35:46)

Il va éviter la survenue des complications. Il faut savoir que lorsqu'on donne un traitement, il y a certains facteurs qui peuvent entraîner la résistance au retard de la cicatrisation. Si le malade

continue à prendre les anti-inflammatoires ou continue à fumer, c'est pour ça que les anti-inflammatoires menstruels doivent être évités chez les patients qui ont un ulcère, sauf si nécessité avec protection.

(35:47 - 36:09)

Il faut proscrire aux patients ayant eu un ulcère le tabagisme. Il faut leur conseiller le sevrage du tabac. Quelles sont les complications de la maladie ulcère? Je commencerai par l'hémorragie digestive qui est la complication la plus fréquente.

(36:09 - 36:31)

Elle est plus fréquente avec l'ulcère duodénal qu'avec l'ulcère gastrique. Elle représente 40% des hémorragies digestives hautes. L'hémorragie digestive peut se manifester soit par des hématoèmes, des mélénaux, des rectorragies, parfois par une mésoptose.

(36:32 - 36:52)

Il peut être grave, mortel. C'est pour ça que c'est des malades qui doivent être repris en charge en urgence en leur proposant un traitement hémostatique. Le traitement en général, le traitement endoscopique reste un traitement efficace.

(36:53 - 37:09)

En cas d'échec, à ce moment là, il faut passer à un traitement radiologique, voire la chirurgie. En absence de traitement, elle est responsable d'un taux de mortalité de 10%. La deuxième complication qui est aussi grave, c'est la perforation.

(37:09 - 37:31)

Là aussi, la perforation est plus fréquente avec l'ulcère duodénal qu'avec l'ulcère gastrique. Elle va donner une douleur en coup de poignard, d'installation brutale très importante avec une contracture invincible abdominale. Il faut penser à l'ulcère gastroduodénal.

(37:31 - 38:00)

On peut mettre en évidence déjà à l'abdomen sans préparation le croissant gazeux sous les deux coupes diaphragmatiques qui est plus visible du côté droit. Ce pneu péritonéal permet de rattacher la péritonite à la perforation d'ulcère. C'est une complication qui est grave, qui nécessite une hospitalisation en urgence avec une prise en charge en urgence.

(38:01 - 38:18)

La troisième complication, c'est la sténose. Là aussi, c'est plus fréquente avec l'ulcère duodénal qu'avec l'ulcère gastrique. Il va être responsable d'une douleur postprandiale tardive avec des

vomissements qui exposent à des troubles immunitaires, à une déshydratation.

(38:18 - 38:36)

Le diagnostic peut être déjà suspecté devant un clapotage gastrique ingénieur. C'est-à-dire qu'on va mobiliser l'abdomen du patient et on va sentir un liquide qui se déplace. C'est ce qu'on appelle le clapotage gastrique.

(38:37 - 39:01)

Pour les sténoses gastroduodinales d'origine ulcéreuse, on peut proposer soit un traitement endoscopique par dilatation, soit un traitement chirurgical. Et on a la quatrième complication qui est le cancer, la dégénérescence. On sait que l'ulcère duodinal ne dégénère jamais.

(39:01 - 39:11)

C'est pour ça qu'on ne le contrôle pas. On ne le surveille pas sauf s'il reste symptomatique. Par contre, l'ulcère gastrique dégénère même si c'est une complication rare.

(39:13 - 39:30)

C'est pour ça que tout ulcère d'abord doit être biopsié. Et après le traitement, il faut le contrôler endoscopiquement et faire des biopsies sur la cicatrice. Et faire un contrôle deux à trois mois après.

(39:31 - 40:00)

Jusqu'à la cicatrisation et la disparition de tous les symptômes. La prise en charge de l'ulcère gastro-duodinal repose sur l'éradication de *mycobactères puloris*, les inhibiteurs de la pompe à proton. L'objectif de traitement, c'est soulager la douleur, soulager le patient, arrêter la douleur et la souffrance du patient.

(40:01 - 40:20)

Accélérer la cicatrisation de l'ulcère duodinal pour éviter les complications. Et surtout prévenir les récurrences des poussées. Pour terminer, la maladie ulcéreuse gastro-duodinale n'est pas exceptionnelle.

(40:20 - 40:44)

Elle est due le plus souvent à *l'Helicobactère pulori* en deuxième temps aux anti-inflammatoires. Il doit être confirmé par une endoscopie qui permet le diagnostic endoscopique. Il faut savoir qu'il faut toujours rechercher le facteur étiologique et donc rechercher *l'Helicobactère puloriquique*.

(40:44 - 41:12)

Le facteur étiologique prépondérant grâce à des biopsies systématiques au niveau de l'entre l'ongulus et le fendus. En cas d'ulcère gastrique, il ne faut pas oublier de faire des biopsies sur l'ulcère lui-même et ses berges. Il faut refaire en cas d'ulcère gastrique l'endoscopie et refaire les biopsies sur la cicatrice pour écarter de façon formelle un cancer.

(41:13 - 41:33)

Bien sûr, le traitement, c'est un traitement étiologique. Il faut éradiquer l'helicobactère pulori pour éviter la récurrence et les inhibiteurs de la pompe à protons qui sont très importants. Et bien sûr, arrêter tous les facteurs favorisants comme le tabagisme, l'alcool, les anti-inflammatoires.

(41:33 - 41:35)

Je vous remercie.